

照护成效中期报告

生成时间：2026-05-18 16:11:58

照护成效中期报告

报告日期：2026年4月15日（返院第14天）

BPSD发作频次变化：

返院初期（第3天）出现1次轻微拒绝配合康复训练事件，此后未再发生任何BPSD相关行为。NPI评分稳定于12分左右，较住院前显著下降。老人情绪整体平稳，无激越、攻击、游走或妄想等表现，可主动参与照护安排。

ADL变化：

日常生活能力持续改善。ADL评分稳步提升，平地行走辅助需求减少，已可在短距离内独立行走。洗澡仍需全程协助，但配合度显著提高，能主动响应照护员指令完成洗浴流程。

进食恢复情况：

饮食规律，食欲正常，无吞咽困难或拒食行为。营养摄入充足，体重稳定，总胆固醇控制在5.8mmol/L，表明代谢状态良好，进食功能完全恢复。

夜间睡眠趋势：

睡眠节律规律，夜间无离床、喊叫或失眠表现。白天精神状态良好，无日间过度嗜睡，提示睡眠质量持续改善。

当前照护重点：

- 维持BPSD症状稳定，预防复发；
- 深化个性化认知干预，结合跳舞喜好开展结构化舞蹈康复训练；
- 支持ADL能力进一步提升，尤其在转移与洗浴环节增强自主性；
- 持续为家属提供认知症照护技巧指导，巩固家庭-机构协同照护机制。

下一阶段目标：

- 实现ADL评分提升至80分以上；
- 将短暂记忆空白频次控制在每周 ≤ 1 次；
- 确保连续14天无BPSD行为事件；
- 家属能独立应用所学技巧应对日常照护挑战。

是否进入稳定期判断：

否。虽整体趋势向好，但尚处于BPSD症状控制后的观察巩固期，需持续监测至少至D30方可判定为稳定期。

****高价值语料标记**：**

- “可主动参与简易舞蹈康复训练”
- “愿意与其他老人一起参与集体舞蹈活动”
- “家属照护焦虑情绪明显缓解，能主动配合照护团队”
- “短暂记忆空白频次较会诊后明显减少（每周1-2次），持续时间缩短”
- “无跌倒、感染、药物不良反应等不良事件”